

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LABORATORIUM ASISTEN KEPERAWATAN

SMKN 1 PAKONG



SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NEGERI 1 PAKONG

**JL. RAYA BANDUNGAN PAKONG
PAMEKASAN**

DAFTAR ISI

i. DAFTAR ISI	1
1. MENCUCI TANGAN	2
2. MEMAKAI MASKER	2
3. MEMASANG HANDSCONE STERIL	3
4. MEMAKAI SCORT ATAU CELEMEK	3
5. MENGUKUR TANDA-TANDA VITAL	4
6. MEMASANG BULI-BULI PANAS DAN KIRBAT ES	6
7. MEMBERI KOMPRES HANGAT DAN DINGIN	8
8. MEMOTONG KUKU	9
9. MENGGOSOK GIGI	10
10. MEMANDIKAN PASIEN	11
11. MEMBANTU BAK DAN BAB	13
12. MELAKUKAN PERAWATAN PERINEUM	14
13. MELAKUKAN PENIS HIGIENE	16
14. MENCUCI RAMBUT	17
15. MEMBANTU PASIEN DUDUK DITEMPAT TIDUR DAN MEMINDAHKAN PASIEN DARI TEMPAT TIDUR KE BRANKARD ATAU KURSI RODA DAN SEBALIKNYA	18
16. MENGGANTI LINEN DENGAN PASIEN DIATAS TEMPAT TIDUR	20
17. MELAKUKAN PERAWATAN SETELAH KLIEN/PASIEN MENINGGAL DUNIA	22
18. PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	23
19. PROSEDUR TINDAKAN PEMBERIAN TERAPI OKSIGEN DENGAN KANUL	25
20. PROSEDUR MEMBERIKAN NEBULIZER	26
21. PROSEDUR TINDAKAN PEMBERIAN OBAT	27
22. MEMASANG INFUS	29
23. CARA MERAWAT LUKA DASAR	31

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

1. MENCUCI TANGAN

Persiapan Alat
• Air mengalir • Handuk bersih atau tisu • Sabun
Tahap Kerja
Mencuci Tangan
1. Membasahi tangan dan lengan bawah dengan air bersih yang mengalir.
2. Tuangkan sabun secukupnya.
3. Menggosok kedua telapak tangan selama 10 -15 detik.
4. Menggosok punggung tangan dan sela- sela jari secara bergantian.
5. Menggosok sela-sela jari bagian dalam bergantian
6. Menggosok jari-jari sisi dalam dan saling mengunci.
7. Menggosok ibu jari kiri berputar dalam genggam tangan kanan dan sebaliknya.
8. Bersihkan sela kuku/ujung jari dengan cara gosokkan ujung jari dengan memutar ditelapak tangan dengan bergantian
9. Membilas lengan dan tangan dengan air bersih yang mengalir.
10. Menutup kran dengan siku.
11. Mengeringkan tangan dengan lab kering atau tisu

2. MEMAKAI MASKER

Persiapan Alat
• Masker
Tahap Kerja
Memakai Masker
1. Cuci tangan
2. Tentukan tepi atas atau bawah masker
3. Pasang masker menutupi hidung dan mulut, kemudian ikat tali-talinya. Tali bagian atas diikat ke kepala belakang melewati bagian atas telinga. Tali bagian bawah diikat ke belakang leher.
4. Tanggalkan masker dengan melepas ikatan tali-talinya, kemudian lipat maskerdengan bagian luar di sebelah dalam
5. Cuci tangan kembali

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

3. MEMASANG HANDSCONE STERIL

Persiapan Alat
• Sarung tangan steril sesuai ukuran (yang masih terbungkus atau re-use yang sudah disterilkan) • Tromol kecil atau baki instrumen steril • Korentang
Tahap Kerja
Memasang Handscone Steril
1. Siapkan peralatan, letakkan set sarung tangan steril pada trolley yang bersih dan kering setinggi atau diatas pinggang
2. Cuci tangan sesuai dengan SOP dan keringkan.
3. Untuk sarung tangan steril yang masih terbungkus: Buka pembungkus sebelah luar dengan hati-hati dengan hanya menyentuh bagian luarnya saja.
4. Untuk sarung tangan steril re-use yang sudah disterilkan: Buka tutup tromol atau baki instrumen, kemudian ambil sarung tangan steril dengan menggunakan korentang
5. Dengan menggunakan tangan yang tidak dominan, ambil ujung sarung tangan steril yang terlipat (untuk sarung tangan re-use steril pegang bagian dalam dari sarung tangan) dan angkat dengan hati-hati dengan ujung jari sarung tangan mengarah ke bawah. Jaga kesterilan dengan menghindari sarung tangan bersentuhan dengan benda yang tidak steril.
6. Masukkan jari-jari tangan ke dalam sarung tangan sesuai tempatnya. Mengatur dan merapikan sarung tangan yang terpasang dengan hanya menyentuh daerah yang steril saja.
7. Dengan tangan dominan yang sudah bersarung tangan masukkan jari-jari tangan (kecuali ibu jari) ke dalam lipatan sarung tangan yang belum terpasang secara hati-hati dan ambil sarung tangan tersebut dengan mengangkat ke atas. Lakukan prosedur pemasangan sama dengan prosedur no 5.

4. MEMAKAI SCORT ATAU CELEMEN

Persiapan Alat
• scort atau celemek
Tahap Kerja
Memakai scort atau celemek
1. Mencuci tangan
2. Peganglah tali penggantung celemek serta masukkan melalui kepala
3. Kedua tali pada sisi kanan dan kiri diikat pada bagian belakang tubuh dengan ikatan yang mudah di lepas
4. Untuk melepas, buka ikatan celemek yang ada dibelakang tubuh
5. Lepaskan celemek melalui kepala
6. Gantung celemek.
7. Mencuci tangan kembali

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

5. MENGUKUR TANDA-TANDA VITAL

Persiapan Alat
• Baki dan pengalas • Bak instrument • Thermometer raksa dalam tempatnya • Alkohol swab • Sphygmomanometer raksa • Stetoskop • Bengkok • Tissue • Arloji/Jam tangan • Buku catatan TTV dan alat tulis • APD (Sarung tangan bersih)
Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja 1
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja 1 yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja 1
Tahap Kerja
Pengukuran Tanda-tanda Vital
Pengukuran Tekanan Darah
1. Mengambil Sphygmomanometer air raksa
2. Mengatur posisi pasien supinasi
3. Menggulung lengan baju pasien sampai di atas siku
4. Memasang manset 2 jari di atas mediana cubiti, selang sejajar arteri brachialis pemasangan manset tidak terlalu longgar dan terlalu ketat
5. Meraba denyut arteri branchialis menggunakan ujung jari 2, 3 jari
6. Mengambil stetoskop dan meletakkan diafragma stetoskop tepat diatas arteri brachialis
7. Menutup sekrup balon, membuka penguci air raksa
8. Memompa balon hingga udara masuk kedalam manset sampai detak arteri brachialis tidak terdengar lagi dan tambahkan 30 MmHg di atas nilai sistolik
9. Membuka sekrup balon perlahan-lahan dengan kecepatan 2-3 MmHg sambil mendengar detak/bunyi denyut pertama (sistol) dan detak/bunyi terakhir (diastole) mata sejajar dengan skala air raksa dengarkan sampai tekanan nol
10. Bila hasil meragukan lakukan validasi dengan mengulangi mulai poin 8-9 (bila hasil pengukuran keduanya beda, ulangi sekali lagi)
11. Melepas manset keluarkan sisa udara yang ada di dalamnya pastikan Sphygmomanometer dalam keadaan Of
12. Kembaliakan Sphygmomanometer dan Stetoskop pada tempatnya
13. Mencatat hasil pengukuran pada buku catatan
Pengukuran suhu

1. Melakukan komunikasi terapeutik dan menjelaskan prosedur tindakan dan memastikan kesiapan pasien
2. Mengatur posisi pasien supinasi
3. Membebaskan axilla pasien pada lengan yang jauh
4. Membersihkan axilla dengan tissue
5. Memeriksa thermometer, pastikan pada skala dibawah 35° C bila belum turunkan dengan cara menggibaskan thermometer
6. Memasang reservoir thermometer tepat pada tengah axilla
7. Menyilangkan tangan di depan dada, memegang bahu
8. Setelah 5-10 menit angkat thermometer
9. Bersihkan thermometer ke arah reservoir menggunakan tisu
10. Membaca hasil dan mencatat hasil pada buku catatan
11. Membersihkan termometer : Dengan mengusap menggunakan alcohol swab kearah reservoir
12. Turunkan thermometer di bawah skala 35° C bila belum turunkan, turunkan dengan cara menggibaskan- ngibaskan thermometer
13. Mengembalikan thermometer kedalam tempatnya
Menghitung Pernafasan
1. Meletakkan tangan pasien di atas abdomen
2. Meletakkan tangan perawat di atas tangan pasien
3. Hitung pernafasan jumlah prekuensi dan iramanya selama 1 menit sebaiknya pasien tidak di ajak bicara
4. Kembalikan tangan pasien ke posisi semula
5. Mencatat hasil pada buku catatan
Menghitung Denyut Nadi
1. Menentukan tempat pengukuran denyut nadi dengan menggunakan ujung jari 2 atau 3 jari (telunjuk, tengah dan manis)
2. Setelah di dapat hitung nadi Frekuensi, irama dan kedalamannya selama 1 menit
3. Mencatat hasil pengukuran pada buku catatan
Tahap Terminasi
1. Merapikan pasien dan membereskan peralatan
2. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
3. Melepaskan APD
4. Mencuci tangan
5. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

6. MEMASANG BULI-BULI PANAS DAN KIRBAT ES

PERSIAPAN ALAT
A. MEMASANG BULI-BULI PANAS • Buli-buli panas/WWZ dan sarungnya • Air panas dalam ceret/tremos • Lap kerja • Perlak kecil • Handuk
B. MEMASANG KIRBAT ES • Eskap/eskrag dan sarungnya • Es dalam tempatnya • Air dalam baskom • Lap kerja • Perlak kecil • Handuk
Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja 1
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja 1 yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja 1
Tahap Kerja
Memasang buli-buli panas
8. Menjaga privacy pasien
9. Memakai APD
10. Mengisi buli-buli panas dengan air yang panasnya 50-60° C, diisi 1/3 – 1/2 bagian
11. Mengeluarkan udara dengan cara melipat bagian yang kosong
12. Menutup buli-buli panas
13. Memeriksa buli-buli panas apakah bocor atau tidak dengan mengangkat buli-buli panas dengan menutupnya mengarah ke bawah
14. Mengeringkan buli-buli panas dengan lap kerja
15. Memasukkan ke dalam sarungnya
16. Membentangkan perlak dan handuk pada daerah yang perlu mendapat buli-buli panas dan menempatkan buli-buli panas pada daerah yang memerlukan
17. Berikan pengompresan berulang 15-30 menit, berikan istirahat setiap 5 menit hingga efek yang diinginkan tercapai
18. Kaji keadaan klien setelah selesai pemberian kompres
19. Jika telah selesai, kembalikan buli-buli panas ketempat semula

Memasang kirbat es
17. Jelaskan tujuan dan prosedur pemasangan kirbat es
18. Memecahkan es, kemudian diaduk dengan air sebentar supaya pinggir pecahan es yang tajam hilang
19. Mengisi kirbat es sebanyak $\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$
20. Mengeluarkan udara dengan cara melipat bagian yang kosong , kemudian ditutup
21. Memeriksa dengan teliti apakah kirbat es bocor atau tidak
22. Mengeringkan kirbat es dengan lap kerja
23. Masukkan kirbat es ke dalam sarungnya
24. Membentangkan perlak dan handuk pada daerah yang perlu mendapat kirbat es
25. Berikan pengompresan berulang 15-30 menit, berikan istirahat setiap 5 menit hingga efek yang diinginkan tercapai
26. Kaji keadaan klien setelah selesai pemberian kompres
27. Jika telah selesai, kembalikan kirbat es ketempat semula
Tahap Terminasi
25. Merapikan pasien dan membereskan peralatan
26. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
27. Melepaskan APD
28. Mencuci tangan
29. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

7. MEMBERI KOMPRES HANGAT DAN DINGIN

PERSIAPAN ALAT
A. MEMBERI KOMPRES HANGAT • Kain kompres/Washlap • Baskom berisi air hangat • Handuk kecil kering B. MEMBERI KOMPRES DINGIN • Kain kompres/Washlap • Baskom berisi air dingin • Handuk kecil kering
Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja
Tahap Kerja
Memberi Kompres Hangat Pada Pasien
8. Menjaga privacy pasien
9. Memakai APD
10. Memasang perlak dan handuk untuk mencegah bed basah
11. Membasahi kain kompres dengan air hangat suhu kira-kira 40° C, peras kain/washlap
12. Meletakkan kain kompres pada daerah yang dikompres (dahi pasien)
13. Menutup kain kompres dengan handuk kering/ kain yang bersih
14. Bila kain kompres telah kering, kurang lebih (5-10 menit) atau suhu kain kompres relative menjadi dingin, maka masukkan kembali kain kompres kedalam cairan kompres dan letakkan kembali di daerah yang dikompres, lakukan berulang hingga efek yang diinginkan tercapai
15. Keringkan daerah yang dikompers dengan handuk
16. Kaji keadaan klien setelah selesai pemberian kompres
17. Rapikan alat
Memberi Kompres Dingin Kepada Pasien
15. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan kompres dingin
16. Memasang perlak dan handuk untuk mencegah bed basah
16. Membasahi kain kompres/washlap dengan air dingin, peras kain/washlap
17. Meletakkan kain kompres pada daerah yang dikompres
18. Menutup kompres dingin dengan handuk kering
19. Lakukan kompres selama kurang lebih (5-10 menit) atau ketika kain penyerap kering
20. Keringkan daerah yang dikompres dengan handuk
21. Kaji keadaan klien setelah selesai pemberian kompres

22. Rapihan alat
Tahap Terminasi
21. Merapikan pasien dan membereskan peralatan
22. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
23. Melepaskan APD
24. Mencuci tangan
25. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

8. MEMOTONG KUKU

Persiapan Alat
• Pengalas (perlak kecil) • Gunting kuku • Handuk • Bengkok berisi desinfektan • Baskom berisi air hangat • Sabun • Sikat kuku • Sarung tangan bersih • Aseton (jika perlu untuk menghilangkan cat kuku) • Kapas • Celemek
Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja 2 yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja
Tahap Kerja
Menggunting Kuku Pasien
8. Menjaga privacy pasien
9. Memakai APD
10. Memasang pengalas di bawahnya kemudian merendam tangan dalam baskom berisi air hangat selama 1-2 menit untuk melunakkan kuku, jika kuku sangat kotor sikat kuku dan sabun kemudian bilas dengan air hangat dan keringkan dengan handuk
11. Meletakkan tangan diatas bengkok berisi lisol 3% supaya kuku tidak berserakan. Potong kuku pada jari tangan sesuai dengan lengkungan kuku
12. Setelah selesai, masukkan gunting kuku kedalam bengkok setelah dipotong, kikir kuku agar rapi, rata dan halus
Tahap Terminasi
13. Merapikan pasien dan membereskan peralatan

14. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
15. Melepaskan alat pelindung diri
16. Mencuci tangan
17. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

9. MENGGOSOK GIGI

Persiapan Alat
• Sikat gigi dengan pasta gigi/ odol • Gelas berisi air bersih • Bengkok 2 buah/ mangkok tempat kumur • Tisu beberapa potong • Alat pengisap/ sedotan • Sarung tangan bersih • Baki • Handuk/ Alas
Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja 2
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja 2 yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja 2
Tahap Kerja
Menggosok gigi
8. Menjaga Privacy pasien
9. Memakai APD
10. Memasang pengalas/ handuk di bawah dagu dan pipi pasien
11. Meletakkan bengkok dibawah dagu klien agar air bekas kumur dapat tertampung dan berikan air untuk kumur-kumur kepada pasien
12. Berikan sikat gigi yang sudah di bubuhi pasta gigi secukupnya dan telah di basahi air terlebih dahulu kepada pasien
13. Berikan kesempatan kepada klien untuk menyikat giginya sampai bersih (bagi pasien yang tidak bisa menggosok gigi sendiri bantu pasien menggosok gigi sampai bersih)
14. Menyarankan untuk kumur-kumur dengan bersih, tampung air dalam bengkok
15. Masukkan sikat gigi kedalam gelas yang telah kosong
16. Keringkan bibir dan sekitarnya dengan menggunakan handuk/ tisu
17. Mengangkat handuk/pengalas, rapikan/atur kembali posisi pasien dengan nyaman
18. Bereskan peralatan sikat gigi dan kembalikan tempatnya
Tahap Terminasi
19. Merapikan pasien dan membereskan peralatan
20. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
21. Melepaskan alat pelindung diri
22. Mencuci tangan
23. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

10. MEMANDIKAN PASIEN

• Pakaian bersih 1 stel • Baskom mandi 2 buah • Air hangat • Washlap 2 buah • Perlak dan handuk kecil 1 buah • Handuk besar 2 buah • Selimut mandi/ kain penutup • Celemek • Tempat tertutup untuk pakaian kotor • Sabun mandi • Bedak • Sarung tangan bersih • Sisir rambut • Rak handuk • Sketsel
Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja 2
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja 2 yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja 2
Tahap Kerja
Memandikan pasien
8. Menjaga Privacy pasien
9. Memakai APD
10. Mengganti selimut pasien dengan selimut mandi kemudian melepas pakaian atas pasien dan menutupnya kembali dengan selimut mandi
11. Membentangkan perlak kecil & handuk kecil di bawah kepala, menawarkan pasien menggunakan sabun / tidak kemudian membersihkan muka, telinga dengan washlap basah dan mengeringkan dengan handuk yang berada di bawah kepala
12. Menggulung perlak & handuk kemudian ditaruh di dalam tempat linen kotor yang tertutup
13. Memasang handuk besar di atas dada kemudian menurunkan selimut mandi ke bagian perut & kedua tangan klien diletakkan diatas handuk
14. Membasahi tangan klien dengan washlap air bersih, disabun kemudian dibilas dengan air hangat (lakukan dari ekstremitas terjauh klien) , dikeringkan dengan handuk yang berada diatasnya

15. Meletakkan kedua tangan yang sudah bersih dibagian kepala mengarah keatas, kemudian membersihkan dada dan perut pasien dari bawah handuk yang menutupi dada,dengan washlap basah, disabun, dibilas dengan air bersih dan dikeringkan dengan handuk yang berada diatas dada pasien
16. Memiringkan pasien kearah perawat dan membentangkan handuk di belakang punggung hingga bokong
17. Membasahi punggung hingga bokong dengan washlap, di sabun kemudian dibilas dengan air hangat & dikeringkan dan memberi bedak pada punggung
18. Mengambil handuk yang berada di bawah punggung untuk di taruh di rak handuk
19. Mengembalikan ke posisi telentang kemudian membantu pasien mengenakan pakaian atas
20. Mengambil handuk yang berada di atas dada untuk dimasukkan ke tempat linen kotor dan
21. Melepas pakaian bawah pasien dengan tetap menjaga privacy pasien
22. Mengambil handuk yang berada di rak handuk untuk di bentangkan dibawah kaki pasien
23. Menekuk kaki, kemudian membasahi kaki mulai dari pergelangan sampai pangkal paha disabun dibilas dengan air bersih kemudian dikeringkan dan melakukan tindakan yang sama untuk kaki yanglain
24. Mengambil handuk dibawah kaki pasien dan meletakkan ketempat linen kotor
Tahap Terminasi
25. Merapikan pasien dan membereskan peralatan
26. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
27. Melepaskan APD
28. Mencuci tangan
29. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

11. MEMBANTU BAK DAN BAB

Persiapan Alat
• Pispot dan urinal • Perlak dan alasnya • Botol berisi air bersih/ botol cebok • Bengkok (nierbekken) • Kapas cebok dalam kom • Tissue kloset • Celemek/apron • Sampiran • Selimut mandi • Sarung tangan bersih
Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja 2
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja 2 yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja 2
Tahap Kerja
Membantu pasien BAB dan BAK
8. Menjaga privacy pasien
9. Memakai APD
10. Memasang selimut mandi dan menurunkan selimut pasien
11. Membuka pakaian bawah pasien
12. Membentangkan perlak dibawah bokong pasien dan menawarkan pasien BAK dan BAB
13. Memasang pispot/urinal di bawah bokong klien, memberikan kesempatan dan keleluasaan pasien untuk BAK dan BAB
14. Mengobservasi karakteristik urine pasien (jumlah, warna)
15. Mengobservasi feses pasien (lembek, encer, keras)
16. Menyiram daerah anus dan genitalia dengan air bersih setelah selesai BAK/BAB , membersihkan daerah anus dan genetalia dengan kapas cebok kemudian dikeringkan dengan tisu, mengambil pispot dibawah bokong pasien. (Kapas bekas cebok dimasukkan dalam pispot)
17. Mengangkat perlak dibawah bokong pasien
18. Mengangkat selimut mandi diganti dengan selimut pasien
Tahap Terminasi
19. Merapikan pasien
20. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
21. Membersihkan peralatan, bawa pispot dan isinya ke spillhock untuk dibuang dan dibersihkan
22. Melepaskan APD
23. Mencuci tangan
24. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

12. MELAKUKAN PERAWATAN PERINEUM

Persiapan Alat
• Bak instrument berisi kom • Duk Steril • Alas bokong • Handscoon Steril dan Bersih • Bengkok • Korentang beserta tempatnya • Tempat baju kotor • Baki / nampan beserta alasnya • Sampiran • Selimut mandi • Kapas DTT dalam kom tertutup • Tisu
Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja 2
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja 2 yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja 2
Tahap Kerja
Melakukan perawatan perineum
8. Menjaga privacy pasien
9. Memakai APD
10. Mengganti selimut pasien dengan selimut mandi
11. Mengatur posisi klien dorsal recumbent
12. Melepaskan pakaian bawah pasien dan meletakkan perlak kecil dibawahnya bokong pasien
13. Membuka duk steril, membuka bak instrumen, mengambil kapas savlon diletakkan di kom steril
14. Melepaskan sarung tangan bersih
15. Menggunakan sarung tangan steril
16. Meletakkan bengkok
17. Membuka vulva dengan ibu jari dan jari telunjuk, bersihkan labia mayora, labia minora, vestibulum dan perineum
18. labia Membersihkan mayor sebelah kanan dari depan ke belakang 1 kapas untuk 1 kali usapanlakukan hingga bersih
19. Membersihkan labia mayor sebelah kiri dari depan ke belakang 1 kapas untuk 1 kali usapanlakukan hingga bersih
20. Membersihkan labia minor sebelah kanan dari depan ke belakang 1 kapas untuk 1 kali usapanlakukan hingga bersih
21. Membersihkan labia minor sebelah kiri dari depan ke belakang 1 kapas untuk 1 kali usapanlakukan hingga bersih
22. Bersihkan permukaan vestibulum hingga perineum dengan sekali usap hingga bersih
23. Mengeringkan dengan tisu kemudian mengambil perlak dan handuk

24. Mengangkat perlak yg berada dibawah bokong pasien
25. Membantu pasien mengenakan pakaian bawah
26. Mengganti selimut mandi dengan selimut pasien
27. Membereskan alat,rapikan pasien
28. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
29. Melepaskan alat pelindung diri
30. Mencuci tangan
31. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan kegiatan

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

13. MELAKUKAN PENIS HIGIENE

Persiapan alat
• Bak instrument berisi bengkok, kom • Alas bokong • Bengkok • Korentang beserta tempatnya • Tempat tempat baju kotor • Baki / nampan beserta alasnya • Sampiran • Selimut mandi • Handscoon Bersih dan Steril • Kapas DTT dalam kom tertutup • Tisu
Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja 2
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja 2 yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja 2
Tahap Kerja
Melakukan perawatan perineum
8. Menjaga privacy pasien
9. Memakai APD
10. Mengganti selimut pasien dengan selimut mandi
11. Mengatur posisi klien dorsal recumbent
12. Melepaskan pakaian bawah pasien dan meletakkan perlak kecil dibawahnya bokong pasien
13. Membuka duk steril, membuka bak instrumen dengan korentang, mengambil kapas savlondiletakkan di kom steril
14. Melepaskan sarung tangan bersih
15. Menggunakan sarung tangan steril
16. Meletakkan bengkok
17. Pegang ujung penis, bila klien belum disirkumsisi, retraksi kulup. tunda prosedur bila klien ereksi
18. Membersihkan ujung penis pada meatus uretra pertama kali, lakukan gerakan memutar, bersihkan meatus uretra ke arah luar,, kembalikan kulup pada posisinya
19. Membersihkan batang penis perlahan sampai ke arah pangkal penis, keringkan penis secara menyeluruh
20. Membersihkan skrotum, angkat testis dengan hati-hati, bersihkan lipatan kulit dibawahnya, keringkan
21. Mengangkat perlak yg berada dibawah bokong pasien
22. Membantu pasien mengenakan pakaian bawah
23. Mengganti selimut mandi dengan selimut pasien
24. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
25. Membereskan alat, rapikan pasien
26. Melepaskan alat pelindung diri
27. Mencuci tangan
28. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan kegiatan

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

14. MENCUCI RAMBUT

Persiapan alat
• Handuk 2 buah • Talang • Peniti/penjepit • Kain pel • Baskom berisi air hangat • Gayung • Sampo • Sisir 2 buah • Kain kasa dan kapas • Ember kosong • Sarung tangan bersih • Bengkok berisi larutan desinfektan • Celemek • Alat pengering rambut
Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja 2
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja 2 yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja 2
Tahap Kerja
Mencuci rambut pasien
8. Menjaga Privacy pasien
9. Memakai APD
10. Mengganti selimut klien dengan selimut mandi
11. Mengatur posisi tidur pasien yaitu kepala di pinggir tempat tidur
12. Memasang handuk dibawah kepala kemudian memasang ember yang dialasi kain pel dan memasang talang dengan ujung berada di dalam ember
13. Menutup dada dengan handuk sampai leher kemudian menyisir rambut dari ujung kepangkal
14. Menutup lubang telinga dengan kapas dan mata dengan kain kassa
15. Menyiram dengan air hangat, menggosok/ memijit kulit kepala dan rambut dengan sampo menggunakan kasa dan membilas rambut dengan air sampai bersih
16. Melepas penutup telinga dan penutup mata kemudian mengangkat talang dan memasukkan kedalam ember bekas air mencuci rambut, mengeringkan rambut dengan handuk kemudian dengan pengering dan menyisir rambut
Tahap Terminasi
17. Merapikan pasien dan membereskan peralatan
18. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
19. Melepaskan alat pelindung diri
20. Mencuci tangan
21. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

15. MEMBANTU PASIEN DUDUK DITEMPAT TIDUR DAN MEMINDAHKAN PASIEN DARI TEMPAT TIDUR KE BRANKARD ATAU KURSI RODA DAN SEBALIKNYA

Persiapan alat
• Sarung tangan • Kursi roda
Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja 2
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja 2 yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja 2
Tahap Kerja
Membantu Pasien Duduk Di Tempat Tidur
8. Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan membantu pasien duduk
9. Mengatur bagian kepala tempat tidur pada posisi datar
10. Mengunci semua roda tempat tidur
11. Berdiri di samping tempat tidur, disisi pantat klien menghadap kearah kepala tempat tidur, melebarkan kaki dengan salah satu kaki di depan dan jadikan kaki ini sebagai tumpuan berat badan
12. Meminta klien untuk meletakkan kedua tangan di sisi tubuhnya dengan telapak tangan menghadap diatas permukaan tempat tidur
13. Mengangkat pasien pada posisi duduk dengan cara tangan kiri perawat berada di belakang leher pasien dan tangan yang satu berada di bawah bahu pasien
14. Meletakkan tangan yang lainnya diatas permukaan tempat tidur dan gunakan untuk mendorong pada saat mengangkat
15. Meminta pasien untuk turut mengangkat secara bersamaan dengan anda, dengan mendorong kedua tangannya diatas permukaan tempat tidur. Angkat dengan menarik bahu pasien menggunakan lengan dan tangan anda, dan pindahkan berat badan anda dari kaki depan ke belakang
16. Memastikan pasien merasa nyaman dengan posisi yang telah di berikan
Memindahkan Pasien Dari Tempat Tidur Ke Kursi Roda
17. Menjelaskan tujuan dan prosedur memindahkan pasien ke kursi roda
18. Merendahkan posisi tempat tidur sampai posisi yang terendah sehingga kaki pasien dapat menyentuh lantai
19. Meletakkan kursi roda sejajar dan sedekat mungkin dengan tempat tidur dalam posisi terkunci
20. Membantu pasien untuk duduk di tepi tempat tidur
21. Mengkaji pasien apakah mengalami hipotensi postural
22. Memberi instruksi yang jelas kepada pasien untuk bergerak kedepan dan duduk di tepi tempat Tidur
23. Berdiri tepat di depan pasien
24. Melingkari punggung pasien dengan kedua tangan, tangan pasien berada di bahu perawat

25.	Membantu pasien untuk berdiri dan menyuruh pasien untuk menurunkan kaki hingga menyentuh lantai
26.	Memberi hitungan untuk mengangkat kaki bersamaan dan menggeser ke kursi roda (jalan seperti biasa)
27.	Meminta pasien untuk membelakangi kursi roda
28.	Membantu pasien untuk duduk
29.	Menjaga kaki berada di depan kursi roda
30.	Meletakkan kedua tangan di atas lengan kursi roda
31.	Meminta pasien untuk menggeser duduknya sampai pada posisi yang paling nyaman
32.	Turunkan tatakan kaki dan letakkan kedua kaki pasien di atasnya
Tahap Terminasi	
33.	Melakukan evaluasi tindakan instruksi kerja
34.	Merapikan pasien
35.	Membereskan semua alat instruksi kerja
36.	Berpamitan dengan pasien
37.	Melepas alat pelindung diri
38.	Mencuci tangan
39.	Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

16. Mengganti Linen Dengan Pasien Diatas Tempat Tidur

Persiapan Alat
• Bed standar • Trolley • Baki dan pengalas • Sprei • Stik laken • Perlak (Zeil) • Sarung bantal • Selimut • Tempat linen kotor bertutup • Larutan desinfektan dalam botol semprot • Lap kerja 3 buah • Hand scoon bersih • Celemek
Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja 1
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja
Tahap Kerja
Mengganti linen dengan pasien di atas Tempat Tidur
8. Menjaga privacy pasien
9. Memakai APD
10. Posisikan pasien pada tempat yang memungkinkan untuk mengganti alat tenun kemudian miringkan pasien ke arah berlawanan dengan perawat dan pasang pengaman tempat tidur (bila ada)
11. Menempatkan bantal dibawah kepala pasien
12. Melepaskan alat tenun dari bawah dimana perawat berdiri
13. Menggulung alat tenun sampai ke punggung pasien
14. Membersihkan tempat tidur sebelah tempat perawat berdiri dengan menggunakan desinfektan
15. Membentangkan spreng bersih memanjang dengan lipatan tengahnya tepat pada bagian tengah tempat tidur
16. Menyisipkan spreng bagian kepala dan kaki ke bawah kasur
17. Membentangkan perlak dan stik laken
18. Menyisipkan spreng dan perlak beserta stik laken ke bawah kasur dari arah kepala ke kaki pasien dengan membentuk sudut
19. Menelentangkan pasien
20. Memiringkan pasien ke arah sisi perawat, bila pasien tidak mampu maka dibantu perawat lain yang memegang atau menahan bagian bahu dan paha pasien dari sisi lain dan memasang pengaman tempat tidur (bila ada)

21. Perawat pindah ke sisi lain dengan membawa alat kebersihan
22. Mengangkat spre, perlak dan stik laken yang kotor dengan bagian kotor berada di dalam dan memasukan ketempat laken kotor
23. Membersihkan tempat tidur seperti yang dilakukan pada sisi sebelumnya
24. Menarik spre bersih, perlak dan stik laken pada punggung pasien lalu bentangkan sampairata
25. Menyisipkan spre, perlak dan stik laken dari bagian kepala ke kaki kebawah kasur kemudian membuat sudut
26. Menelentangkan pasien
27. Mengangkat bantal, diratakan isinya dan diganti sarungnya dengan yang bersih, lalu diletakan kembali dibawah kepala pasien
28. Mengganti selimut yang kotor dengan yang bersih kemudian menyisipkan selimut bagian kaki ke bawah kasur
Tahap Terminasi
29. Merapikan pasien dan membereskan peralatan
30. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
31. Melepaskan APD
32. Mencuci tangan
33. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

17. MELAKUKAN PERAWATAN SETELAH KLIEN/PASIEN MENINGGAL DUNIA

Persiapan Alat
• Kain panjang atau selimut • Gunting verban, • Bengkok • Tempat pakaian kotor (Plastik) • Kapas • Kassa gulung • Sarung tangan • Formulir jenazah
Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja 1
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Berpamitan dengan pasien sebelum tindakan melakukan perawatan jenazah
Tahap Kerja
Melakukan perawatan setelah klien/pasien meninggal dunia
7. Menjaga privasi pasien (Menutup sampiran) & memakai APD
8. Memberi penjelasan kepada keluarga tentang meninggalnya klien/pasien dan tindakan yang akan dilakukan
9. Memberikan kesempatan kepada keluarga untuk melihat jenazah dan memasang sampiran
10. Menempatkan tubuh jenazah dalam posisi supinasi
11. Menyingkirkan pakaian dan alat tenun, serta melepas semua alat kesehatan pada tubuh jenazah
12. Menempatkan kedua tangan jenazah diatas abdomen, mengatupkan rahang dan mengikat jenazah(kepala, tangan, paha, betis, ibu jari)
13. Menutup lubang
14. Menutup jenazah dengan kain panjang/selimut dan memberi kartu identitas atau tanda pengenal/label pada jenazah
15. Mencatat semua milik jenazah dan memberikan kepada keluarga
Tahap Terminasi
16. Membereskan peralatan
17. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
18. Melepaskan alat pelindung diri
19. Mencuci tangan
20. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

18. PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN

- Pengertian
Melaksanakan pemeliharaan alat-alat keperawatan dan alat kedokteran dengan cara membersihkan, mendesinfektan, menyeterilkan dan menyimpannya
- Tujuan
Sebagai acuan untuk pemeliharaan alat medis dan keperawatan

A. Pemeliharaan Peralatan dari Logam
1. Membersihkan dan desinfektan :
a. Peralatan : • Alat kotor • Larutan Chlorine, gelas pengukur • Bak/ember tempat merendam • Air mengalir
b. Prosedur : • Memakai sarung tangan • Membersihkan alat dari kotoran yang melekat dibawah air kran mengalir • Dikeringkan (setelah kering dimasukan kesteroilisator)
2. Menyeterilkan dan Penyimpanan Alat Logam
a. Peralatan : • Alat-alat logam • Sterilisator • Panas kering • Kain pembungkus bila perlu
b. Prosedur : • Memakai panas kering (sterilisator) • Menyusun alat-alat ke dalam bak instrumen dalam keadaan bersih/kering • Membungkus bak instrumen berisi alat dengan kain • Memasukkan alat ke dalam autoclave (sentral) selama 30 menit untuk yang dibungkus, 20 menit untuk yang tidak dibungkus. • Mengangkat alat dari sterilisator dan menyimpan dalam tempatnya
B. Pemeliharaan Tensi Meter
• Mengunci air raksa setelah pemakaian alat. • Menggulung kain beserta manset dan disusun / dimasukkan ke dalam baktensimeter. • Menutup tensimeter dan menyimpan pada tempatnya. • Kain manset dicuci bila kotor atau satu kali seminggu. • Perhatikan kaca pengukur harus tetap dalam keadaan bersih dan mudah dibaca.
C. Membersihkan Dan Mendesinfeksi Serta Menyimpan Pispot
a. Peralatan • Pispot + urinal kotor. • Sarung tangan • Larutan desinfektan (karbol) • Bak septik tank
• Keranjang sampah. • Bak/ ember tempat merendam. • Lap bersih dan kering. • Sikat bertangkai
b. Prosedur

- Membawa pispot yang kotor ke dalam spoel hoek.
- Memakai sarung tangan.
- Membuang tissue bekas pakai keranjang ke keranjang sampah, dengan memakai korentang spoel hoek
- Membuang kotoran ke bak septik tank, kemudian mengalirkan air kransupaya kotoran masuk tangki septik tank. Membilas alat dari kotoran yang masuk, melekat dengan mempergunakan sikat bertangkai
- larutan desinfektan sampai semua permukaan pispot terendam.
- Membersihkan pispot dengan cara menyikat memakai air sabun/ detergen.
- Membilas pispot di bawah air mengalir
- Merendam pispot di bak /ember tempat perendam yang berisi (bayclin)
- Mengeringkan pot dengan kain lap.
- Menyimpan pot pada tempatnya.

D. Membersihkan Dan Mendesinfeksi Serta Menyimpan Urinal

a. Peralatan

- Urinal yang kotor.
- Sarung tangan
- Larutan desinfektan (karbol)
- Bak septik tank.
- Bak/ ember perendam
- Lab bersih dan kering
- Sikat

b. Prosedur

- Membawa urinal ke kamar spoel hoek.
- Memakai sarung tangan.
- Membuang urinal ke bak septik tank.
- Membilas urinal dengan air.
- Merendam urinal dalam bak/ ember yang berisi larutan desinfektan sampai semua permukaan urinal terendam (konsentrasi sama dengan perendaman pispot)
- Memberihkan dengan cara menyikat memakai sabun/detergen
- Membilas urinal dibawah air mengalir
- Mengeringkan urinal dan menggantungkannya ditempatnya

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

19. Prosedur Tindakan Pemberian Terapi Oksigen dengan Kanul

Persiapan Alat
• Tabung Oksigen dengan flowmeter • Humidifier dengan air steril di dalamnya • Kanule nasal • Plaster
FASE PRAINTERAKSI
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
FASE ORIENTASI
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja
FASE KERJA
8. Menjaga privasi
9. Mengatur posisi yang nyaman (semi fowler atau semi fowler)
10. Menjelaskan prosedur pada klien dan keluarga
11. Memastikan volume air steril dalam tabung pelembab sesuai ketentuan
12. Menghubungkan selang dari kanula nasal ke tabung pelembab/humidifier
13. Memeriksa apakah oksigen keluar dari kanula
14. Memasang kanula/outlet pada hidung klien
15. Meletakkan kanule di atas wajah klien dengan kanule/outlet masuk hidung dan selang mengelilingi kepala atau menyelipkannya pada daun telinga. Beberapa model mempunyai pengikat dibawah dagu.
16. Jika kanule tidak pada tempatnya, plester pada sisi wajah, selipkan kasa di bawah selang pada tulang pipi untuk mencegah iritasi
17. Menetapkan kadar oksigen sesuai program medik.*
18. Menganjurkan klien untuk bernapas melalui hidung dengan mulut tertutup
19. Mengkaji respon langsung klien terhadap oksigen, seperti warna pernafasan, ketidaknyamanan dan sebagainya. Memberi dorongan/support ketika diputuskan pemakaian kanule.
FASE TERMINASI
20. Merapikan klien dan alat
21. Mencuci tangan
22. Mengevaluasi respon klien
23. Mengucapkan salam
24. Mendokumentasikan prosedur dalam catatan klien: waktu pemberian, aliran kecepatan oksigen, rute pemberian, dan respons klien

Catatan :

Kewaspadaan Observasi apakah:

- Kanula tersumbat atau terlipat
- Tabung pelembab/humidifier kurang cukup terisi air
- Volume Oksigen mencukupi/tidak

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

20. Prosedur Memberikan Nebulizer

Persiapan Alat
• Oksigen set • Nebulizer set • Cairan normal saline dan obat yang akan dipakai • Sput 5 atau 10 cc. • Bengkok • Tisu
Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja
Tahap Kerja
Prosedur Memberikan Nebulizer
1. Menjaga privacy pasien
2. Memakai APD
3. Monitor <u>vital sign</u> sebelum dan sesudah pengobatan khususnya pada klien yang menggunakan bronkodilator.
4. Atur posisi klien nyaman mungkin paling sering dalam posisi semifowler
5. Nebulizer diisi obat (sesuai program pengobatan) dan cairan normal salin ± 4-6cc.
6. Hidupkan nebulizer kemudian hubungkan nebulizer dan selangnya ke flow meter oksigen dan set aliran pada 4-5 liter/menit
7. Memasang masker sesuai wajah klien
8. Instruksikan pasien untuk nafas dalam sehingga droplet obat terhirup
9. Selesai tindakan, anjurkan klien untuk batuk setelah tarik nafas dalam beberapa kali (teknik batuk efektif).
Tahap Terminasi
10. Membereskan peralatan
11. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
18. Melepaskan alat pelindung diri
19. Mencuci tangan
20. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

21. Prosedur Tindakan Pemberian Obat

Persiapan Alat	
A. Injeksi IM,IV, IC, SC	• Spuit 3cc / 5cc • Spuit 1cc / spuit insulin(intra kutan) • Kapas Alkohol • Obat untuk Injeksi • Sarung tangan • Bengkok • Bak injeksi
B. Pemberian Obat Supositoria	a. Supositoria rektal . (<i>suppositoria harus disimpan dalam lemari es agar tidak meleleh</i>) b. Jeli pelumas (larut air) c. Sarung tangan sekali pakai d. Tisu e. Duk
FASE PRAINTERAKSI	
1.	Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2.	Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja
3.	Dekatkan alat ke dekat pasien
4.	Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
FASE ORIENTASI	
5.	Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6.	Jelaskan intruksi kerja yang akan dilakukan
7.	Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja
FASE KERJA	
8.	Menjaga privasi klien
9.	Memakai sarung tangan
10.	Mengatur posisi klien
11.	Memasang pengalas
Injeksi Intramuskuler (IM)	
1.	Mengambil obat sesuai dengan dosis yang akan diberikan. Letakan pada bak injeksi
3.	Menentukan area penyuntikan
4.	Melakukan desinfeksi pada area yang ditentukan
5.	Melepaskan tutup jarum dengan menggunakan teknik satu tangan
6.	Mengangkat kulit sedikit dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri ,
7.	menusukkan jarum dengan sudut 90° dari kulit (tegak lurus dengan permukaan kulit)
8.	Lakukan aspirasi untuk menentukan tidak mengenai pembuluh darah, jika tidak ada darah masukkan obat secara perlahan-lahan
9.	Memasukkan obat pelan-pelan
10.	Mencabut jarum sambil menekan tempat tusukan dengan kapas
11.	alkohol. Massage bagian tsb
12.	Menutup jarum dengan teknik satu tangan
13.	Periksa area suntikan untuk memastikan tidak ada perdarahan, pembengkakan atau reaksi-reaksi lain yang terjadi
14.	Melepas sarung tangan
15.	Mengembalikan klien pada posisi yang nyaman
Injeksi Intravena (IV) langsung	
1.	Menyiapkan obat yang akan disuntikkan

2. Mencari lokasi penyuntikan dan bebaskan dari pakaian (cari daerah yang terlihat jelas venanya)
3. Memasang perlak dan alas dibawah daerah yang akan disuntik
4. Membendung area di atas vena yang akan diinjeksi dengan
5. menggunakan torniquet
6. Melakukan desinfeksi pada area yang ditentukan
7. Meregangkan kulit sedikit dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, tusukkan jarum ke dalam vena dengan lubang jarum menghadap keatas, dengan sudut 20°
8. Lakukan aspirasi untuk mengetahui apakah jarum sudah masuk
9. kedalam vena yang ditandai dengan darah masuk kedalam tabung spuit (jika tidak ada darah masukkan sedikit lagi jarum sampai terasa masuk vena).
10. Buka karet pembendung (torniquet) dan anjurkan klien membuka kepalan tangannya, masukkan obat secara perlahan jangan teralucepat
11. Meletakan kapas alkohol yang baru diatas jarum, cabut jarum dari kulit secara dengan agak cepat
Injeksi Intracutan (IC)
1. Menentukan area penyuntikan
2. Melakukan desinfeksi pada area yang ditentukan
3. Melepaskan tutup jarum dengan menggunakan teknik satu tangan
4. Memasukkan jarum dengan sudut 15°-20°, dengan tangan yang tidak dominan meregangkan area sekitar penyuntikan*
5. Memasukkan obat pelan-pelan sampai tampak bulatan menonjol
6. Menarik jarum dan jangan melakukan masage. Tandai bulatan yang
7. menonjol dengan pena serta menganjurkan klien untuk tidak menekand daerah benjolan.
8. Menutup jarum dengan teknik satu tangan
9. Mengambil perlak dan pengalas
10. Melepas sarung tangan
11. Mengembalikan klien pada posisi yang nyaman
Injeksi Subkutan (SC)
43. Menentukan area penyuntikan
44. Melakukan desinfeksi pada area yang ditentukan
45. Melepaskan tutup jarum dengan menggunakan teknik satu tangan
46. Memasukkan jarum dengan sudut 45°, dengan tangan yang tidak dominan meregangkan area sekitar penyuntikan
47. Memasukkan obat pelan-pelan
48. Mencabut jarum sambil menekan tempat tusukan. Massage bagian tsb kecuali kontraindikasi
49. Menutup jarum dengan teknik satu tangan
50. Melepas sarung tangan
51. Mengembalikan klien pada posisi yang nyaman
Obat Supositoria
1. Membantu klien pada posisi Sim, jaga agar hanya pada bagian anus saja yang terbuka
2. Keluarkan supositoria dari bungkusnya, lumasi ujung supositoria dan tangan yang dominan dengan dengan jely atau pelumas larut air
3. Minta klien tarik nafas dalam dengan perlahan melalui mulut agar spingter anus relaksasi*
4. Retraksi bokong (merenggangkan glutea) dengan tangan tidak dominan. Masukka supositoria dengan perlahan melalui anus melalui sfingter anal internal dan kearah dinding rektum, 10 cm pada dewasa 5 cm pada anak dan bayi*.
5. Menarik jari tangan dan membersihkan area sekitar anal dengan tisu
6. Menganjurkan klien untuk menahan ±15 menit agar obat tidak keluar sehingga

bereaksi optimal
7. Melepas sarung tangan
FASE TERMINASI
1. Merapikan klien dan alat
2. Mengevaluasi respon klien
3. Mencuci tangan
4. Mengucap salam
5. Mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan

22. MEMASANG INFUS

Persiapan Alat
• Standart infus. • Cairan infus. • Infus set. • Abocath • Alkohol swab. • Sarung tangan • Kasa steril • Betadine • Torniket • Pengalas dan perlak. • Gunting. • Plester • Bengkok. • Petunjuk waktu/jam • Catatan
Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja 2
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
5. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
6. Jelaskan intruksi kerja 2 yang akan dilakukan
7. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja 2
Tahap Kerja
Memasang Infus
1. Menjaga privacy pasien
2. Siapkan plester potong sesuai kebutuhan
3. Gantungkan cairan infus pada tiang infus
4. Buka kemasan set infus dan pengatur klem rol sekitar 2-4 cm dibawah bilik drip dan menutup klem yang ada pada saluran infus
5. Tusukkan pipa saluran infus kedalam botol cairan dan mengisi tabung tetesan dengan cara memencet tabung tetesan infus hingga setengahnya
6. Buka klem dan mengalirkan cairan keluar sehingga tidak ada udara pada slang infus
7. Buka kemasan abocath dan letakkan abocath kedalam bak steril
8. Pasang perlak dan pengalasnya dibawah daerah yang akan dipasang infus
9. Pilih Vena yang akan dipasang dipasang infus, bila banyak bulu,guntinglah
10. Letakkan torniket 10-12 cm diatas tempat yang akan ditusuk,anjurkan klien untuk menggegam tangannya
11. Pasang sarung tangan

12. Lakukan desinfeksi daerah penusukan dengan kapas alkohol (melingkar dari dalam keluar)dengan diameter +- 5 cm
13. Tusukkan jarum abocath ke vena (15-30 O)dengan lubang jarum menghadap keatas ,dengan menggunakan tangan yang dominan
14. Lihat apakah darah terlihat pada pipa abocath
15. Masukkan abocath secara perlahan serta menarik secara perlahan jarum yang ada pada abocath, sehingga platik abocath masuk semua dalam vena dan jarum keluar semua
16. Tahan kateteter dengan satu tangan, minta klien untuk melepaskan genggamannya
17. Lepaskan tornilet dan dengan cepat hubungkan adpter jarum dengan set infus,jangan menyentuh adapter
18. Buka pengatur tetesan dan alirkan cairan
19. Beri ddan menutupndengan kasaespnfeksi daerah tusukan dengan menggunakan betadine
20. Lakukan fiksasi
21. Atur kecepatan aliran infus sesuai program
Tahap Terminasi
1. Merapikan pasien dan membereskan peralatan
2. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
3. Melepaskan alat pelindung diri
4. Mencuci tangan
5. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan (tuliskan jumlah tetesan,tanggal,dan waktu pemasangan)

CARA MENGHITUNG TETESAN INFUS MAKRO DAN MIKRO

Set infus mikro sering dipakai untuk klien dewasa karena pada set infus ini, debit cairan yang dikeluarkan lebih besar sehingga diharapkan pemenuhan cairan untuk klien lebih cepat. Sementara itu, set infus mikro seringkali digunakan untuk klien anak-anak karena debit cairan yang dikeluarkan 3kali lebih sedikit dibandingkan set infus mikro

Rumus dasar dalam hitungan menit adalah sebagai berikut :

$\text{Jumlah tetesan per menit} = \frac{\text{Jumlah kebutuhan cairan x faktor tetes}}{\text{Waktu (menit)}}$
--

Rumus dasar dalam jam adalah sebagai berikut :

$\text{Jumlah tetesan per menit} = \frac{\text{Jumlah kebutuhan cairan x faktor tetes}}{\text{Waktu (jam) x 60 menit}}$

Keterangan

Faktor tetes dewasa = 20
Faktor tetes anak = 60

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ASISTEN KEPERAWATAN SMK NEGERI 1 PAKONG

23. CARA MERAWAT LUKA DASAR

Persiapan Alat
• Bak instrumen yang berisi : • Pinset 3 buah (2 anatomis dan 1 sirugis) • Sarung tangan steril 1 pasang • Gunting (sesuai kondisi luka) • Balutan dan kasa steril • Depper • Lidi kapas • Kom 2 buah (untuk larutan antiseptik dan larutan pembersih) • Sarung tangan bersih sekali pakai 1 pasang • Salep antiseptik • Larutan NaCl 0,9% • Gunting Perban • Plester • Bengkok 2 (untuk larutan lysol/kosong) • Perlak dan pengalas • Kantong sekali pakai • Buku Catatan
Tahap Pra Interaksi
1. Pelajari data tentang klien/pasien sebagai persiapan melakukan pekerjaan
2. Siapkan alat sesuai dengan intruksi kerja
3. Dekatkan alat ke dekat pasien
4. Lakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan
Tahap Orientasi
6. Sampaikan salam terapeutik pada klien/pasien
7. Jelaskan intruksi kerja 2 yang akan dilakukan
8. Tanyakan kesiapan pasien dalam tindakan intruksi kerja
Tahap Kerja
Cara Merawat Luka Dasar
9. Menjaga Privacy pasien
10. Ambil kantong sekali pakai dan buat lipatan diatasnya. Letakkan kantong dan bengkok dekat klien
11. Atur posisi klien sehingga luka dapat terlihat jelas
12. Pasang perlak dan pengalas dibawah daerah luka
13. Gunakan sarung bersih sekali pakai dan lepaskan plester dan balutan dengan menggunakan pinset
14. Lepaskan plester yang dimulai dari ujung kearah balutan dan menariknya dengan perlahan. jika, jika masih menempel dikulit, bersihkan dengan alkohol
15. Jika balutan lengket dengan luka, lepaskan dengan memberikan larutan NaCl, lepaskan secara perlahan
16. Buang balutan kotor pada bengkok kosong dan lepaskan sarung tangan , lalu letakkan dibengkok yg berisi lysol
17. Buka bak instrument dengan tetap mempertahankan tehnik steril
18. Tuangkan larutan kedalam kom
19. Gunakan sarung tangan steril
20. Inspeksi luka, perhatikan kondisi luka, letak drain, Jahitan, penutupan kulit dan karakter luka
21. Bersihkan luka dengan larutan antiseptik dan larutan NaCl 0,9%
22. Pegang kasa yang sudah dibasahi larutan dengan menggunakan pinset dan satu kasa untuk satu kali usapan bersihkan dari mulai dari daerah kurang terkontaminasi ke area terkontaminasi
23. Gunakan kasa kering untuk mengeringkan luka

24. Berikan salep antiseptik sesuai program
25. Pasang kasa steril kering pada insisi atau letak luka
a. Pasang satu kasa sebagai lapisan kontak
b. Jika terdapat Drain, ambil gunting potong tengah kasa
c. Pasang kasa lapisan kedua
d. Pasang bantalan kasa tenun yang lebih tebal
23. Gunakan plester diatas balutan dan lakukan fiksasi
Tahap Terminasi
26. Merapikan pasien dan membereskan peralatan
27. Evaluasi tindakan kepada pasien dan berpamitan dengan pasien
28. Melepaskan alat pelindung diri
29. Mencuci tangan
30. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan